

ICCA 中介資料庫 Schema

醫院端定時把 Philips ICCA 的資料寫進由醫院端建置與維護的中介資料庫，廠商唯讀取用。

生命徵象是即時的儀器量測（每 5 分鐘一批）；其他臨床資料為非即時的人工填寫，同樣每 5 分鐘檢查一次，有新增或修改的紀錄就寫入、沒有就不寫，內容可能是事後補填或修改的。

版本 v0.3 (草案) 日期 2026-08-06 作者 Vicky Wu 資料來源 Philips ICCA 涵蓋範圍 成人加護病房 介接方式 唯讀帳號或 API (由醫院端決定)

主機 醫院端提供專用 Server 維護 醫院端

目前僅涵蓋成人加護病房，不含兒醫、麻醉、健檢、產房、牙醫、OR、POR 等單位。

管路資料不走Portal，與Jesse再確認是否走床頭卡的 API 直接傳送。

三個階段資料撈取

分階段納入。標「資料待確認」的項目屬非即時資料，內容與頻率尚未定案。

階段一

核心監測

生命徵象	每 5 分鐘
神經學狀態	非即時 · 資料已確認
呼吸器	非即時 · 資料已確認
Scoring	非即時 · 資料待確認

階段二

輸液與管路

IO 進出量	非即時 · 資料待確認
管路	是否從床頭卡 API 直傳·待確認

階段三

治療與支持

藥物	非即時 · 資料待確認
營養	非即時 · 資料待確認
儀器	非即時 · 資料待確認

本文 §2、§3 描述的兩張表是階段一的內容；階段二、三納入時以新增資料或新增欄位的方式進來，既有欄位不變動。管路不走中介資料庫，由床頭卡的 API 直接傳送，介面另行說明。

00 權責分工

中介資料庫是醫院端的資產：2026-08-06 與資訊室主任的會議中討論確認，由醫院端提供一台專用 Server 來放這個資料庫，建置、寫入、備份、清理與保留期限都由醫院端負責，廠商如何取用（唯讀帳號或 API）也由醫院端決定。廠商不需要準備任何主機或資料庫。

[來源](#) · [PHILIPS](#)

Philips ICCA 資料庫

院內既有的臨床資訊系統。

系統與資料正確性：**Philips**

撈取：**醫院端**

排程拋轉



每天不間斷
每 5 分鐘一輪
兩張表同時撈

[中介](#) · [醫院端建置維護](#)

中介資料庫 (MS SQL Server)

`dbo.CDSUnvalidatedData`
`dbo.CISData`

跑在醫院端提供的專用 Server 上。每輪寫入該時段的資料；時間窗大於間隔，重複的靠鑰匙去重。

主機、建置、備份、清理：**醫院端**

保留期限由醫院端決定（見 §6 Q2）

唯讀取用



唯讀帳號 或 API
由醫院端決定
走 API 時憑醫院端核發的 token

[讀取](#) · [廠商](#)

其他廠商系統（如研華）

依醫院端指定的方式唯讀取用，自行保存水位線做增量讀取（見 §4）。

存取控制：**醫院端自行開發**——走 API 時由醫院端核發 token，依 token 在醫院端篩選可回傳的範圍

讀取與後續處理：**廠商**

醫院端只寫、廠商只讀，交界就是這兩張表；廠商拿不到中介資料庫以外的任何權限。拋轉中斷時廠商會看到資料停止增加，核對方式見 §5。

項目	負責方	說明
ICCA 來源系統	Philips	ICCA 本身的維護與資料正確性；醫院端只以唯讀帳號撈取
中介資料庫主機、執行個體	醫院端	2026-08-06 與資訊室主任會議討論確認，由醫院端提供一台專用 Server；建置、備份、修補、容量規劃都在醫院端，廠商不需準備主機
建表與索引	醫院端	DDL 見 §2、§3；醫院端 DBA 建立，其他廠商不需要任何 DDL 權限
寫入與排程	醫院端	每 5 分鐘一輪，兩張表同時撈，失敗自動於下一輪重試
舊資料清理	醫院端	依需求設定保留期限及排程（見 §6 Q2）
寫入中斷的偵測與告警	醫院端	服務日誌與資料落後監控都在醫院端；貴司要自行核對的方式見 §5
取用方式與帳號	醫院端決定並核發	開唯讀帳號直接查表，或由醫院端提供 API（token 由醫院端核發，並依 token 在醫院端篩選資料範圍）；廠商提供來源 IP 與需求，醫院端開通（見 §6 Q1）
讀取邏輯與後續處理	其他廠商	水位線的保存、資料的解讀與運用

01 共通約定

兩張表共用以下規則。

項目	約定
資料庫	Microsoft SQL Server，跑在 醫院端提供的專用 Server 上（2026-08-06 會議確認，見 §0）。兩張表在同一個資料庫、同一個 schema（預設 <code>dbo</code> ）。實際的伺服器位址、執行個體與資料庫名稱隨帳號一併核發（見 §6 Q1）。
存取方式 醫院端決定	兩種做法 由醫院端擇一 ，欄位定義與內容相同： 唯讀帳號——直接查表，只有這兩張表的 <code>SELECT</code> 權限。醫院端只寫不讀，建議查詢加 <code>WITH (NOLOCK)</code> 避開寫入當下的鎖。 醫院端提供 API——廠商不直接連資料庫。存取控制走醫院端核發的 token，每次呼叫帶著它；能拿到哪些資料由醫院端依 token 篩選後才回傳。
編碼	文字欄位一律 <code>NVARCHAR</code> （Unicode），含中文標籤如「昏迷指數」。
時間欄位 已定案	臨床時間（ <code>measurementTime</code> 、 <code>chartTime</code> ...）型別是 <code>DATETIME</code> ，值是 台灣時間（UTC+8） ，不帶時區標記。 稽核時間（ <code>insertedAt</code> 、 <code>updatedAt</code> 、 <code>changedAt</code> ）值同樣是 台灣時間（UTC+8） ——它們是資料庫伺服器蓋的 <code>SYSDATETIME()</code> 。全表 只有一種時間基準 ，臨床時間與稽核時間可以直接相減。
空值	以 <code>NULL</code> 表示，不會用空字串。例外見 §2、§3 的鑰匙欄位說明。
寫入節奏	每 5 分鐘一輪，兩張表同時撈；該輪沒有新資料就不寫 ，不會產生空批次。一批是一個交易， 要嘛整批進去、要嘛整批沒有 ，不會讀到寫到一半的狀態。 生命徵象是 即時量測 ，寫進來就不再變；臨床紀錄是 非即時 的人工填寫， <code>chartTime</code> 可能遠早於寫入時間，也可能事後被改（見 §3）。
資料量	生命徵象約每批 1,800 列、每天 50 萬列 上下，隨在床數浮動；臨床紀錄目前遠小於此，但會隨納入的表單項目增加而成長（見下方「後續擴充」）。
保留期限	由醫院端排程清理， 期限依廠商需要而定 （見 §6 Q2）。未確認之前不會刪除任何資料——但也請勿把本表當成長期歷史庫使用，需要留存的資料請自行複製一份。
後續擴充	生命徵象 的量測項目已固定，後續不會增加。 臨床紀錄 的表單項目則會持續納入新的類別，項目清單是開放式的。因此請以下列方式實作： 不要用 <code>SELECT *</code>，明確列出需要的欄位——新增欄位時貴司才不會受影響。 不要假設 <code>terseLabel</code> / <code>interventionId</code> 的域值固定，會隨時出現沒看過的值。 - 已定義欄位的名稱與型別不會變動，只會新增。

一筆紀錄一列。兩張表都已經攤平：病歷號跟著每一列走，不需要 join 別的表就能解讀單獨一列。
去重已經在醫院端做掉了。寫入時比對唯一鍵，重複的不會產生新的列——貴司讀到的表已經是乾淨的，不必再實作去重邏輯。詳見 §4。

dbo.CDSUnvalidatedData

每 5 分鐘寫入一批

時效 即時 (監視器量測)	寫入頻率 每 5 分鐘一輪，有新資料才寫	每批涵蓋 寫入前約 6 分鐘	粒度 一列 = 一位病人一項目一時 間點	每日列數 約 50 萬
--------------------	-------------------------	-------------------	----------------------------	----------------

結構

```
CREATE TABLE dbo.CDSUnvalidatedData (
  lifetimeNumber NVARCHAR(32) NOT NULL, -- 唯一鍵
  terseLabel NVARCHAR(32) NOT NULL, -- 唯一鍵
  displayLabel NVARCHAR(64) NOT NULL, -- 唯一鍵
  measurementTime DATETIME NOT NULL, -- 唯一鍵
  numericValue FLOAT NULL,
  storeTime DATETIME NULL,
  isDelete BIT NOT NULL DEFAULT (0),
  insertedAt DATETIME NOT NULL DEFAULT (SYSDATETIME()),
  updatedAt DATETIME NULL,
  changedAt AS (ISNULL(updatedAt, insertedAt)) PERSISTED,
  CONSTRAINT PK_CDSUnvalidatedData PRIMARY KEY CLUSTERED
    (lifetimeNumber, terseLabel, displayLabel, measurementTime) -- 唯一鍵就是主鍵
);
```

欄位

欄位	型別	可為 NULL	說明
lifetimeNumber	nvarchar(32)	否	病歷號，唯一鍵的第一欄。查不到病歷號的量測不會寫進本表 (見 \$5)，所以這一欄不會是 NULL。床號不在本表——同一床會換病人、同一位病人也會轉床，一律以病歷號認人。
terseLabel	nvarchar(32)	否	量測項目，例如 HR、ABP、SpO2、CVP。
displayLabel	nvarchar(64)	否	細項，例如 systolic、diastolic、mean。單值項目 (如 HR) 是空字串 ''，不是 NULL——它是唯一鍵的一部分。
measurementTime	datetime	否	儀器量測到的時間 (UTC+8)。臨床上以此為準，時序圖表請用這一欄。
numericValue	float	是	量測數值，可能含小數。單位由項目本身決定，不另設單位欄位。
storeTime	datetime	是	ICCA 端寫入的時間 (UTC+8)，通常略晚於 measurementTime 數秒。
isDelete	bit	否	作廢註記。0 = 有效、1 = 這筆在 ICCA 已經被刪除或作廢。醫院端不會實際刪除列，只把這一欄改成 1 並更新 updatedAt，所以下游用 changedAt 增量讀取時讀得到這個變化 (見 \$4)。取用資料時請一律加 WHERE isDelete = 0。
insertedAt	datetime	否	本列第一次寫進本表的時間 (UTC+8)。
updatedAt	datetime	是	本列最後一次被更新的時間 (UTC+8)。從未更新過則為 NULL。
changedAt	datetime	否	計算欄位 ISNULL(updatedAt, insertedAt) (UTC+8)，已建索引。增量讀取請用這一欄，見 \$4。

資料範例

LIFETIMENUMBER	TERSELABEL	DISPLAYLABEL	MEASUREMENTTIME	NUMERICVALUE	STORETIME	INSERTEDAT (UTC+8)	UPDATEDAT (UTC+8)	CHANGEDAT (UTC+8)
A123456	HR		2026-07-22 11:24:00	88	2026-07-22 11:24:05	2026-07-22 11:25:11.402	NULL	2026-07-22 11:25:11.4
A123456	ABP	systolic	2026-07-22 11:24:00	118	2026-07-22 11:24:05	2026-07-22 11:25:11.402	NULL	2026-07-22 11:25:11.4
A123456	ABP	diastolic	2026-07-22 11:24:00	78	2026-07-22 11:24:05	2026-07-22 11:25:11.402	NULL	2026-07-22 11:25:11.4
A123456	ABP	mean	2026-07-22 11:24:00	91.3	2026-07-22 11:24:05	2026-07-22 11:25:11.402	NULL	2026-07-22 11:25:11.4
A234567	SpO2	SpO2msmt	2026-07-22 11:24:00	97	2026-07-22 11:24:06	2026-07-22 11:25:11.402	NULL	2026-07-22 11:25:11.4
A345678	CVP		2026-07-22 11:24:00	9	2026-07-22 11:24:07	2026-07-22 11:25:11.402	NULL	2026-07-22 11:25:11.4

底色那三列是同一次血壓量測：ABP 靠 displayLabel 分收縮 / 舒張 / 平均，所以是三列而不是一列；HR 這種單值項目的 displayLabel 是空字串而不是 NULL。沒有床號欄位，病人一律以 lifetimeNumber 認；查不到病歷號的量測整列不寫入 (見 \$5)。updatedAt 幾乎永遠是 NULL——儀器讀值寫進來就不會再變。臨床時間與稽核時間都是台灣時間 (UTC+8)，同一個基準，可以直接相減看落後多久。

識別一個量測項目要用 `terseLabel` + `displayLabel` 兩欄。單看 ABP 無法分辨是收縮壓、舒張壓還是平均動脈壓。

已降頻。監視器可能每幾秒送出一次，醫院端已先篩選為「每位病人、每分鐘、每項目最新一筆」，表中不會有秒級的原始資料。

只包含對得到病歷號的量測。空床、測試中的儀器，以及病人對應系統暫時查不到病歷號的那一輪，都不會寫進來（見 \$5）。

本表只有監視器送出的量測，不是「全部的生命徵象」。目前的項目是 HR、SpO2、ABP、CVP、NBP、PAP、ICP。體溫不在這張表——它是護理師填在表單上的，寫進 `dbo.CISData`（見 \$3）。找不到某個項目時請先查對照清單，不要用「它是生命徵象所以應該在這裡」推論。

本表的列寫進去之後不會再變。儀器讀值不會被修改，`updatedAt` 一律是 `NULL`。

03 資料表二：神經評估或其他臨床資料

護理師填在表單上的紀錄都走這張表，項目不限於神經評估。

dbo.CISData

每 5 分鐘一輪 · 有新資料才寫

時效 非即時 (人工填寫)	寫入頻率 每 5 分鐘一輪 · 有新資料才寫	每批涵蓋 寫入前約 6 分鐘	粒度 一列 = 一位病人一項目一時 間點	項目清單 開放式，將持續擴充
--------------------	---------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------

本表不只神經評估。裝的是「護理師填在表單上的紀錄」，依資料來源而不是臨床領域分表——所以呼吸照護與體溫也在這裡：

領域	項目	項數
神經評估	昏迷指數、瞳孔大小、四肢肌力	6
鎮靜 / 譫妄	RASS 分數、ICDSC、疼痛指數	3
呼吸照護	FiO2 %、PaO2	2
呼吸及檢驗紀錄表	FiO2 %、Ventilator Mode.	2
生命徵象及治療紀錄-Scoring	APACH II、TISS、TISS-PICU、SOFA、UA/NSTEMI	5
生命徵象	體溫(°C)	1

體溫請到本表找，不在 dbo.CDSUnvalidatedData。它是人工填寫而非儀器上傳，因此走這條管線。

結構

```
CREATE TABLE dbo.CISData (
  interventionId NVARCHAR(36) NOT NULL, -- 唯一鍵
  chartTime DATETIME2(0) NOT NULL, -- 唯一鍵
  lifetimeNumber NVARCHAR(32) NOT NULL,
  terseLabel NVARCHAR(32) NULL,
  terseForm NVARCHAR(32) NULL, -- 不含單位
  verboseForm NVARCHAR(256) NULL, -- 含單位
  storeTime DATETIME NULL,
  isDelete BIT NOT NULL DEFAULT (0),
  insertedAt DATETIME NOT NULL DEFAULT (SYSDATETIME()),
  updatedAt DATETIME NULL,
  changedAt AS (ISNULL(updatedAt, insertedAt)) PERSISTED,
  -- 另有醫院端內部使用的病人識別欄位，與下列兩欄共同構成唯一鍵，不對外開放
  CONSTRAINT PK_CISData PRIMARY KEY CLUSTERED
    (病人識別欄位, interventionId, chartTime) -- 唯一鍵就是主鍵
);
```

欄位

欄位	型別	可為 NULL	說明
interventionId	nvarchar(36)	否	評估項目的識別碼 (GUID) 。比 terseLabel 穩定，對照表請以此為鍵。
chartTime	datetime	否	這筆紀錄在臨床上代表的時間 (UTC+8) 。時序請用這一欄，不是寫入時間。
lifetimeNumber	nvarchar(32)	否	病歷號。查不到病歷號的紀錄不會寫進本表 (見 \$5) ，所以不會是 NULL 。
terseLabel	nvarchar(32)	是	項目名稱，例如「昏迷指數」、「RASS」、「體溫」。尚未建檔時為 NULL 。
terseForm	nvarchar(32)	是	實際填寫的值，不含單位，例如 E4V5M6 、 37.2 、 -2 。是文字不是數值，要算數值請自行轉型。
verboseForm	nvarchar(256)	是	同一筆填寫值的完整版本，含單位，例如 37.2 °C 、 40 % 。要直接顯示給人看用這一欄；要運算請用 terseForm 。來源沒有提供時為 NULL 。
storeTime	datetime	是	ICCA 端最後寫入的時間 (UTC+8) 。紀錄被修改時這一欄會變新。
isDelete	bit	否	作廢註記。0 = 有效、1 = 這筆在 ICCA 已經被刪除或作廢。醫院端不會實際刪除列，只把這一欄改成 1 並更新 updatedAt ，所以下游用 changedAt 增量讀取時讀得到這個變化 (見 \$4) 。取用資料時請一律加 WHERE isDelete = 0 。
insertedAt	datetime	否	本列第一次寫進本表的時間 (UTC+8) 。
updatedAt	datetime	是	本列最後一次被更新的時間 (UTC+8) 。有值就代表這筆紀錄被改過。
changedAt	datetime	否	計算欄位 ISNULL(updatedAt, insertedAt) (UTC+8) ，已建索引。增量讀取請用這一欄，見 \$4 。

資料範例

INTERVENTIONID	CHARTTIME	LIFETIMENUMBER	TERSELABEL	TERSEFORM	VERBOSEFORM	STORETIME	INSERTEDAT (UTC+8)	UPDATEDAT (UTC+8)	
9B1DEB4D_0C0F	2026-07-31 11:20:00	A123456	昏迷指數	E3V4M6	E3V4M6	2026-07-31 12:05:12	2026-07-31 11:25:07.118	2026-07-31 12:05:41.900	
6F9619FF_D011	2026-07-31 11:20:00	A123456	RASS 鎮靜程度評估表	-2	-2 輕度鎮靜	2026-07-31 11:24:03	2026-07-31 11:25:07.118	NULL	
A0EEBC99_6655	2026-07-31 11:00:00	A123456	體溫(°C)	37.2	37.2 °C	2026-07-31 11:06:08	2026-07-31 11:25:07.118	NULL	
1B4E28BA_B18D	2026-07-31 11:00:00	A123456	FIO2 %	40	40 %	2026-07-31 11:06:08	2026-07-31 11:25:07.118	NULL	
9B1DEB4D_0C0F	2026-07-31 11:00:00	A234567	昏迷指數	E1VTM4	E1VTM4	2026-07-31 11:12:04	2026-07-31 11:25:07.118	NULL	

GUID 為版面而縮寫，實際是完整 36 字元；changedAt 未列出 (= ISNULL(updatedAt, insertedAt)) 。

底色那列示範就地更新：E4V5M6 12:05 被改成 E3V4M6，storeTime、updatedAt 變新，但還是同一列——請以唯一鍵做 upsert 而不是 append 。

第 3、4 列是體溫與 FIO2，不是神經評估但一樣在本表；最後一列是另一位病人的同一個項目 (同

interventionId、不同 lifetimeNumber) 。

terseForm 是不含單位的值、verboseForm 是含單位的完整版本；兩者內容相同時 (如昏迷指數) 看起來會一樣。

評估項目是開放清單，請勿寫死。目前的項目 (昏迷指數、RASS、ICDSC、FIO2、PaO2、體溫) 只是起點，後續會持續納入新的評估類別，terseLabel 與 interventionId 都會出現沒看過的值。

建議以 interventionId 為鍵維護一張可由設定調整的對照表；遇到未知項目請保留原始值並記錄，不要丟棄整列。需要對照表時醫院端可隨時提供最新清單。

本表的列會被就地更新。護理師可以回頭修改已經填過的紀錄。同一筆紀錄再次出現時，醫院端會覆蓋原本那一列的 terseForm 等欄位並更新 updatedAt，不會產生新的列。

因此貴司若把資料複製到自己的表，請以唯一鍵 (見 \$4) 做 upsert，不要單純 append，否則會保留已經被修正的舊值。

這不是在床病人清單。只有在該時段內「有新增或修改紀錄」的病人才會被寫入。某位病人這一小時沒有新填的紀錄，表裡就不會出現新的列——這不代表他出院或沒有病歷。

因此請勿以本表判斷病人是否在床，也不要以「未出現」推論任何臨床狀態。

04 怎麼只讀新的資料

醫院端不會刪除或搬移資料，表會一直長大。貴司若要定時同步，請用 `changedAt` 當水位線（`watermark`）。

建議寫法

```
-- @last = 上一次同步時記下的水位線（第一次跑給一個很早的時間）
SELECT lifetimeNumber, terseLabel, displayLabel,
       numericValue, measurementTime, storeTime, isDelete, changedAt
FROM   dbo.CDSUnvalidatedData WITH (NOLOCK)
WHERE  changedAt > @last    -- 作廢的列也要讀進來，才知道要作廢自己那一份
ORDER BY changedAt, lifetimeNumber, terseLabel, displayLabel, measurementTime;

-- 這一輪讀到的最大值就是下一次的 @last
```

本表沒有流水號欄位。就算有，它也只在新增時往上長，臨床紀錄那種**就地更新**的列不會改變流水號——拿它當水位線會漏掉所有的修改，所以一律用 `changedAt`。

為什麼不是用 `measurementTime` / `chartTime`。那是臨床時間，不是寫入時間。補撈歷史資料時會出現「臨床時間很舊、但剛剛才寫進來」的列，以臨床時間當水位線一樣會漏掉。

`changedAt` 已建索引（`IX_*_changed`），上面那個查詢走 `index seek`，不會全表掃描。

作廢是用 `isDelete` 表達的，不是刪除。增量讀取時**不要**加 `isDelete = 0`——那樣會讀不到「這筆被作廢了」這個變化；請把整批讀進來，再依 `isDelete` 決定是新增 / 更新還是作廢自己那一份。對外呈現資料時才加 `WHERE isDelete = 0`。

水位線請用「已讀到的最大 `changedAt`」，並用 `>` 而不是 `>=`。同一毫秒內可能有多列，`ORDER BY` 再帶上唯一鍵的欄位可確保順序穩定。

保守一點的做法是把水位線往回退幾秒（例如 `@last - 5 秒`）再查，重疊的部分靠 `upsert` 吸收——本表的唯一鍵讓重複讀取是安全的。

去重：醫院端已經做掉了

資料表	唯一鍵	同一把鍵再次出現時
CDSUnvalidatedData	lifetimeNumber + terseLabel + displayLabel + measurementTime	不新增列、也不更新——儀器讀值寫進來就不會再變。
CISData	病人識別碼（醫院端內部）+ interventionId + chartTime	不新增列。 <code>storeTime</code> 較新時 就地更新 該列（ <code>terseForm</code> 、 <code>terseLabel</code> ...）並蓋上 <code>updatedAt</code> 。

醫院端每一輪撈的是「最近 N 分鐘」，時間窗刻意開得比排程間隔大，所以相鄰兩輪必定重疊——但重疊的部分在寫入時就被唯一鍵擋掉了，不會變成表裡的重複列。

05 需要預期的情況

以下都是正常運作下會出現的狀況，請勿視為資料錯誤。

情況	表上的表現	建議處理
該時段確實沒有資料	那段時間沒有新的列	正常，這不是故障
病人資料暫時查不到	那一輪的量測 整列不寫入 ，表上就是少了那段時間的資料	約定是 認不出是誰的資料不進表 ——沒有病歷號的列不會出現，也不會用床號代替。病人對應恢復之後的輪次會照常寫入，但 中斷期間的量測不會回頭補 （環狀表只留約 26 小時）
項目標籤尚未建檔	<code>terseLabel</code> 為 <code>NULL</code> ， <code>interventionId</code> 正常	保留原始值並回報醫院端補上對照，不要丟棄整列
部分加護單位查詢失敗	該單位的病人這一輪沒有新列，其餘照常寫入	缺漏會在後續輪次補回，不必特別處理
紀錄被護理師修改	<code>dbo.CISData</code> 的既有列被更新， <code>updatedAt</code> 有值，不會多一列	以 <code>upsert</code> 覆蓋自己那一份，見 §3 的提示
紀錄在 ICCA 被刪除或作廢	該列的 <code>isDelete</code> 變成 <code>1</code> ， <code>updatedAt</code> 有值，列本身留著	把自己那一份也標成作廢或移除； 不要 因為讀到 <code>isDelete = 1</code> 就略過該列
整段時間完全沒有新列	醫院端可能已經斷線，也可能真的沒資料—— 表上分不出來	醫院端有服務日誌與落後告警，會主動處理。貴司若要自行核對，用 <code>SELECT DATEDIFF(MINUTE, MAX(insertedAt), SYSDATETIME()) FROM dbo.CDSUnvalidatedData</code> ，超過 15 分鐘即為異常

06 需要確認的事項

主機、資料庫的建置、寫入與維運都在醫院端——專用 Server 已於 2026-08-06 與資訊室主任的會議中確認由醫院端提供，廠商不需要準備硬體。以下三項確認後即可開通；時間格式已定案，見 §1。

Q1	取用方式與帳號 要開唯讀帳號直接查表、還是走醫院端提供的 API，由醫院端決定。 採 API 時，token 由醫院端核發，可取用的資料範圍在醫院端依 token 篩選後才回傳
Q2	資料要保留多久 每天約 50 萬列。醫院端會依貴司需要的期限設定清理排程（例如「保留 7 天」）。 若貴司會把資料完整複製一份到自己的系統，這裡可以設得短一些（例如3天），中介庫就只當緩衝用。
Q3	表結構確認 請確認可接受 §2、§3 的表名、欄位名稱與型別。若貴司已有既定的命名慣例，現在調整成本最低；一旦開始寫入就要考慮既有資料的搬移。